

04

皮膚障害

手足症候群・ざ瘡様皮疹・爪囲炎

1 薬剤の分類マップ

EGFR阻害薬 ざ瘡様皮疹・乾燥・爪囲炎	抗EGFR抗体 セツキシマブ パニツムマブ EGFRチロシンキナーゼ阻害薬 ゲフィチニブ エルロチニブ アファチニブ ダコミチニブ オシメルチニブ
マルチキナーゼ阻害薬 限局的な手足症候群	VEGFR等を阻害 レゴラフェニブ ソラフェニブ スニチニブ レンバチニブ
細胞障害性抗がん薬 びまん性の手足症候群・爪障害	フッ化ピリミジン系 カペシタビン S-1 フルオロウラシル その他 ドセタキセル リポソーム化ドキシソルピシン
支持療法 予防と治療	保湿剤 ヘパリン類似物質 尿素製剤 白色ワセリン 外用ステロイド 部位・重症度で強さを選択 皮疹の予防内服 ミノサイクリン ドキシサイクリン

☒ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 重症度(CTCAE Grade)と保険薬局での対応

軽い — 重症度 — 重い		
Grade1	Grade2	Grade3
手足症候群 痛みのない発赤・腫れ・角化	手足症候群 痛みを伴う変化、身の回り以外の生活に支障	手足症候群 強い痛み、身の回りの生活に支障
ざ瘡様皮疹 体表面積の10%未満の丘疹・膿疱	ざ瘡様皮疹 10～30%、または生活や気持ちへの影響あり	ざ瘡様皮疹 30%超で身の回りの生活に支障、感染を伴う
保険薬局での対応 予防のスキンケアと外用薬の使用を継続	保険薬局での対応 外用ステロイドの強さ・使い方を確認し、処方医へ情報提供	保険薬局での対応 休薬の判断が必要。至急処方医へ連絡

手足症候群のGrade2以上は、経口薬の休薬が必要になることが多い。自己判断の中止・継続を防ぐため、連絡先を事前に共有

3 副作用の特徴と発現時期

	開始日	1週	2週	1か月	2か月	3か月～
● 手足症候群(マルチキナーゼ阻害薬)		開始後2～4週以内				
● ざ瘡様皮疹(EGFR阻害薬)		1～4週でピーク				
● ICIの皮疹・かゆみ				3～6週間頃が多い		
● 皮膚乾燥・かゆみ(EGFR阻害薬)				1か月前後から		
● 手足症候群(カペシタビン等)				数週～数か月で徐々に		
● 爪囲炎(EGFR阻害薬)					1～2か月以降	
● 色素沈着(フッ化ピリミジン系)					数か月以降	
● 重症薬疹(粘膜症状・水疱)	いつでも起こりうる					

☒ 重篤・特に注意 ☒ その他

押さえておきたいポイント

1. 皮膚障害は薬剤の系統で型が違う。EGFR阻害薬の皮疹、マルチキナーゼ阻害薬の手足症候群を区別
2. 治療開始時からの保湿・スキンケアが基本。量と回数は実演で伝え、残量で使用状況を確認
3. 発熱・粘膜症状・水疱を伴う皮疹は重症薬疹を疑い、すぐに受診